

5. L'accouchement, l'allaitement et la reprise des cycles

I. Introduction (*voir support slide 5*)

II. Rappel sur la grossesse L'accouchement

III. L'accouchement

1. Les hormones
2. Manifestations physiques

IV. Le post partum

1. Manifestations physiques
2. Manifestations psychiques
3. Les hormones

V. L'allaitement

1. Le colostrum
2. Le lait
3. Manifestations psychiques
4. Les hormones

VI. La reprise des cycles

1. Manifestations psychiques
2. Les hormones

VII. Conclusion

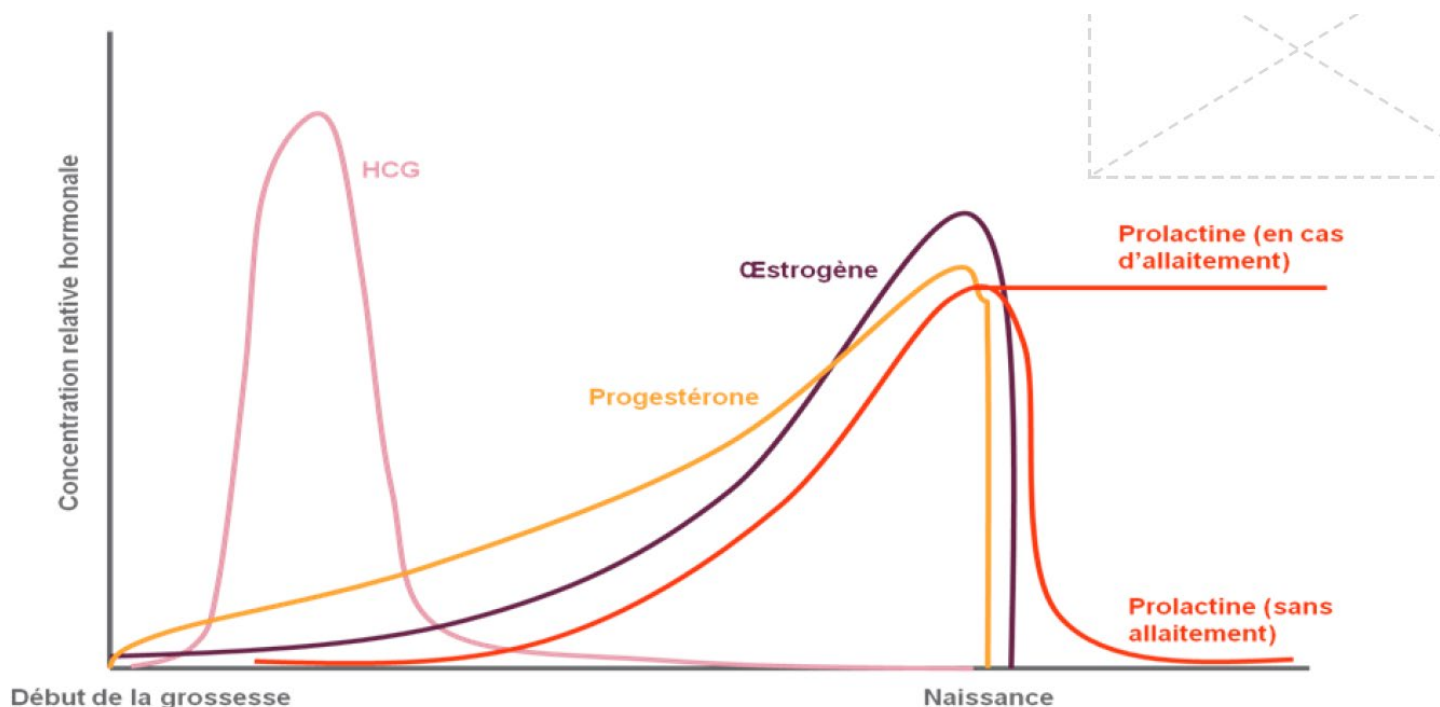
II. RAPPEL SUR LA GROSSESSE

Tout son corps c'est adapté tout au long de la croissance de cet enfant

Lors de la grossesse **les hormones** ont contribué à l'adaptation du corps de la mère et à la croissance du fœtus. Elles sont **produites par la mère, le placenta, l'enfant**.

Le **placenta** protège l'enfant, le nourrit et produit des hormones tout au long de la grossesse.

Les taux d'hormones augmentent tout au long de la grossesse jusqu'à l'accouchement.



<https://www.omum.fr/img/cms/blog/wp/225/08-31-2012-Les-hormones-durant-la-grossesse-3.png>

III. L'ACCOUCHEMENT

1. Les hormones

La **date prévue d'accouchement** est calculée en fonction de la **date du début des dernières règles** ou en fonction de la **date d'ovulation** (celle-ci est égale à la date du début des dernières règles plus 14 jours).

Cette date d'ovulation représente la date de début de grossesse. Pour obtenir la date de l'accouchement nous ajoutons 39 semaines pour connaître la date d'accouchement théorique.

L'accouchement se déclenche à la suite de **plusieurs facteurs** mais surtout liée aux hormones. C'est une **interaction d'hormones entre la mère et l'enfant**.

En fin de grossesse, **les œstrogènes ont un taux très haut, les progestérone elles restent en plateaux**.

Le **taux important d'œstrogènes** permet d'augmenter le **taux de récepteurs à l'ocytocine** sur les cellules de l'utérus.

Cette action des œstrogènes est déjà ressentie par la mère lors de contractions irrégulières depuis quelques mois.

La progestérone avec ses effets myorelaxant évite le déclenchement de l'accouchement.

Ocytocine : Hormone du plaisir, de l'attachement. Produite par le placenta en grande partie au moment de l'accouchement et pendant l'allaitement, c'est l'**axe hypothalamo- hypophysaire**. Production accrue lors de la dilatation du col et de l'utérus et lors de la succion du mamelon.

Elle provoque la **contraction des muscles de l'utérus, sa rétractation après l'accouchement** et la **délivrance du placenta**. Elle permet **l'excrétion du lait** lors de la tétée grâce à la **contraction des glandes mammaires**.

L'hypophyse du **fœtus lui aussi produit elle aussi une petite quantité d'ocytocine**.

Le taux important d'ocytocine de la mère ajouté à celui (moins important) à celui de l'enfant vont avoir une **action sur le placenta** qui va se mettre à **secréter des prostaglandines** (molécules qui ont différents effets physiologiques dans l'organisme, ici elles vont stimuler l'utérus).

L'ocytocine et les prostaglandines vont **intensifier et rendent régulières les contractions utérines**.

En parallèle, la mère subit **de plus en plus un stress physique et psychique** : son corps est mis à mal par **ce bébé qui grossit de plus en plus** en elle et qui lui demande de plus en plus d'énergie.

Elle sait qu'elle va bientôt accoucher et cela provoque également un stress.

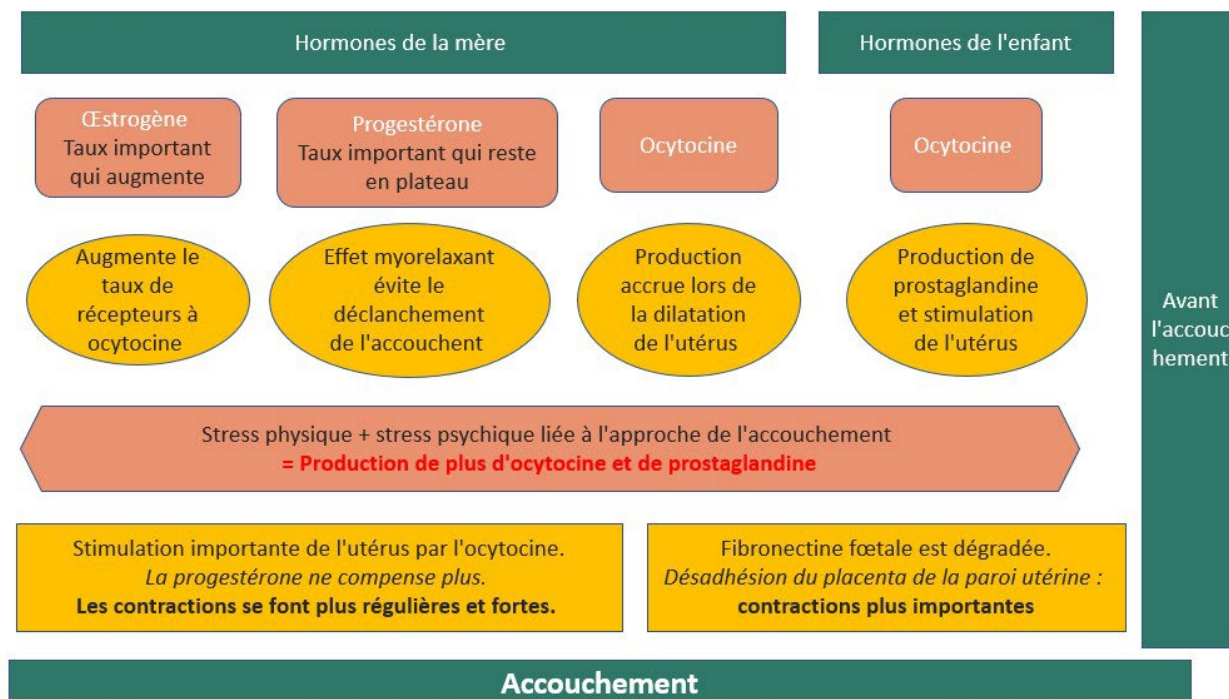
Ces deux facteurs de stress déclenchent dans **l'hypophyse maternelle une production d'ocytocine plus importante**.

Ce taux d'ocytocine important vient stimuler la **production de prostaglandine** par les tissus de l'utérus recouverts de récepteurs à ocytocine.

La stimulation de l'utérus est importante entraine une augmentation accrue du taux d'ocytocine et les contractions se font plus fortes et plus régulières...

Par ailleurs :

- Une glycoprotéine placentaire, **la fibronectine fœtale** (qui permet la fixation du fœtus à l'endomètre) subit une **dégradation** et **il y a désadhésion du placenta à la paroi utérine**.
- **Cela favorise également les contractions et le travail.**



Vidéo voir support slide 21

2. Manifestation physique

Accouchement par voie basse sans problématiques particulières

3 phases

Phase	Temps	Manifestation
La dilatation	Entre 2 et 18 heures	Dilatation et disparition du col Contraction utérine régulières et importantes avec une fréquence et une intensité progressive
L'expulsion	30 min à 1 heure	Engagement : La tête de l'enfant se présente dans le bassin. Descente : Descente de l'enfant le long du vagin. Dégagement : L'enfant sort enfin.
La délivrance	20 à 30 min	Phase d'expulsion du placenta. 15 à 20 min après la naissance de l'enfant. Le placenta se décolle. Passage dans le vagin. Expulsion du placenta et rétractation utérine.

Attention ses données sont variables et dépendent de chaque femme et chaque accouchement.

La dilatation :

Phase la plus longue.

Elle correspond à la **disparition et à la dilatation du col**.

Cette phase est **précédée de la perte du bouchon muqueux**.

Ce bouchon est une glaire pleine de cellules desquamées.

Il se détache quelques jours avant le début de la phase de dilatation ou au moment même du début des contractions.

Cette perte peut passer inaperçue et ne signifie pas que le travail commence.

Le début de la phase de dilatation est marqué par le **début de contractions utérines importantes** et plus ou moins régulières.

Parfois, la perte du bouchon muqueux et la perte des eaux accompagnent ce début de phase.

Au début, les contractions peuvent être espacées de 30 minutes.

Les contractions permettent l'effacement du col ainsi que sa dilatation.

Elles ont **une durée, une fréquence et une intensité progressive**.

La douleur ressentie par la future maman est variable et dépendante de chaque mère.

Les contractions débutent au sommet de l'utérus, elles descendent jusqu'au col.

A la fin de la contraction le muscle se relâche totalement mais est plus court que précédemment ce qui permet l'ouverture du col et l'expulsion du bébé.

L'expulsion

Cette phase comprend 3 étapes :

- **L'engagement**
- **La descente**
- **Le dégagement**

C'est la phase la plus délicate de l'accouchement.

Elle débute lorsque la femme commence à fournir des **efforts d'expulsions**.

Celle-ci peut ressentir une **irrépressible envie de pousser**.

À la suite de l'expulsion, **le cordon ombilical** de l'enfant est **clampé puis coupé**.

À la suite de l'examen, l'enfant est rendu à sa mère pour qu'ils commencent à créer des liens qui sont importants et primordiaux.

Le "peau à peau" est pratiqué.

L'enfant peut alors répondre à **son réflexe de fouissement** (il se dirige vers le sein pour venir téter).

Ce qui va permettre à la mère **d'activer sa production de lait**.

La délivrance

La délivrance correspond à la phase **d'expulsion du placenta**.

Cette phase se fait en moyenne **15 à 20 min après la naissance de l'enfant**.

Elle répond à 3 étapes :

- **Le placenta se décolle** grâce à la rétractation utérine.
- **Passage dans le vagin. Entraîné par le poids**, les **contractions utérines** et **l'hématome retro placentaire**.
- **L'expulsion du placenta**. Cette étape est alors suivie d'une **rétractation utérine qui permet l'hémostase**.

Vidéo voir support slide 33

La dilatation du col dépend de plusieurs facteurs :

- **Le raccourcissement des fibres utérines**
- **L'augmentation de la pression intra-utérine**
- **La pression de la poche ou de la tête de l'enfant**

Si la **poche des eaux** est toujours présente, **elle peut se rompre à tout moment** pendant la phase de dilatation.

Lors de **l'engagement**, la tête de **l'enfant se présente dans le bassin**.

Les contractions se poursuivent et le **foetus entame sa descente le long du vagin**.

Le **dégagement** à lieu **lorsque l'enfant sort enfin**.

Il est possible mais très rare que l'enfant naisse alors que la poche des eaux n'est pas percée.

Après l'accouchement, la femme ressent encore de légères **contractions qui permettent à l'utérus de récupérer sa position initiale**.

Des saignements appelés **"Lochies"** sont également présents.

Le col rétréci et retrouve progressivement son aspect naturel.

Commence alors la **phase de Post-partum** qui **s'étendra jusqu'au retour des règles**.

IV. LE POST PARTUM

1. Manifestations Physique

Période entre l'accouchement et le retour des règles.

- L'utérus reprend sa forme initiale
- Le vagin et le périnée retrouvent leur tonicité
- Les lochies (pertes de sang après l'accouchement) diminuent
- Les seins produisent du colostrum puis du lait

Le corps de la femme qui a pris 9 mois pour s'adapter à la croissance du fœtus doit se réadapter en quelques semaines après l'accouchement.

Possible apparition de troubles (désagréments) :

- Troubles digestifs
- Insomnies
- Hémorroïdes
- Troubles urinaires.

Le retour de couche se fait entre 1 à 5 mois après l'accouchement sauf s'il y a présence d'un allaitement complet de l'enfant.

2. Manifestations Psychique

Période de gros bouleversement pour la mère liée à :

- La variation importante d'hormones
- Le changement de rythme familiale
- Modification corporels rapides et importantes.

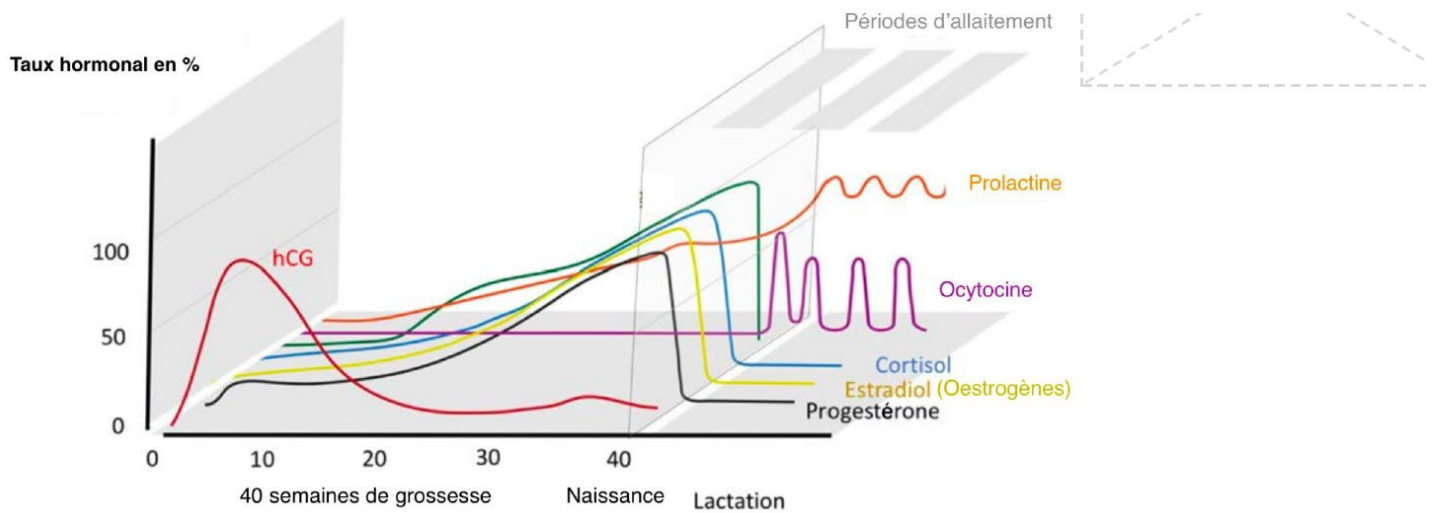
Peu entrainer un baby blues dans les jours qui suivent l'accouchement, 50 à 80 % femmes sont concernées. Il peut débuter dès le 3^{ème} jour après l'accouchement et se termine généralement dans la semaine après l'accouchement. Il est la résultante du **bouleversement hormonal**, du **gros travail physique** qu'à provoqué l'accouchement chez la mère. **C'est un trouble transitoire et non pathologique.**

3. Les Hormones

- La progestérone : Chute brutale suite à la délivrance du placenta
- Les œstrogènes : Chute brutale suite à la délivrance du placenta

Si allaitement :

- ♦ L'ocytocine : Production régulière afin de **favoriser l'éjection du lait**, fait suite au pic lors de l'accouchement.
- ♦ La prolactine : Production régulière afin de **favoriser la production de lait**, produite pendant la grossesse mais l'action était inhibée par la présence des oestrogènes et de la progestérone.



<https://bonjourmalo.fr/blog/hormones-et-grossesse>

V. L'ALLAITEMENT

1. Le colostrum

Juste après l'accouchement, les seins **produisent tout d'abord du colostrum**. *Première tétée* se fait dans les **30 min** qui suivent la naissance

Substance riche en :

- **Eau**
- **Protéines**
- **Anticorps** : la plus part de ces anticorps n'ont pas pu passer la barrière du placenta au moment de la grossesse. Le colostrum est alors la seule manière qu'a la mère de donner ses anticorps à son enfant. Elle dépend également de la perméabilité de l'intestin qui lors des premiers jours après la naissance laisse encore passer quelques grosses molécules.
- **Oligosaccharides** : viennent stimuler le microbiote grâce à leur rôle de prébiotiques.

2. Le lait

Première montée de lait 2 à 3 jours après l'accouchement

Deux types de lait : le **transitionnel** (allaitement après la sécrétion du colostrum) puis le **lait mature**. La production peut aller jusqu'à 1 L par jour. La production s'arrête d'elle-même en 1 à 2 semaine si la maman n'allaité plus.

Le **taux de lipides et de lactose augmente** alors que le **taux de protéine diminue**.

Deux protéines de lait le composent :

- La caséine
- Le lactosérum

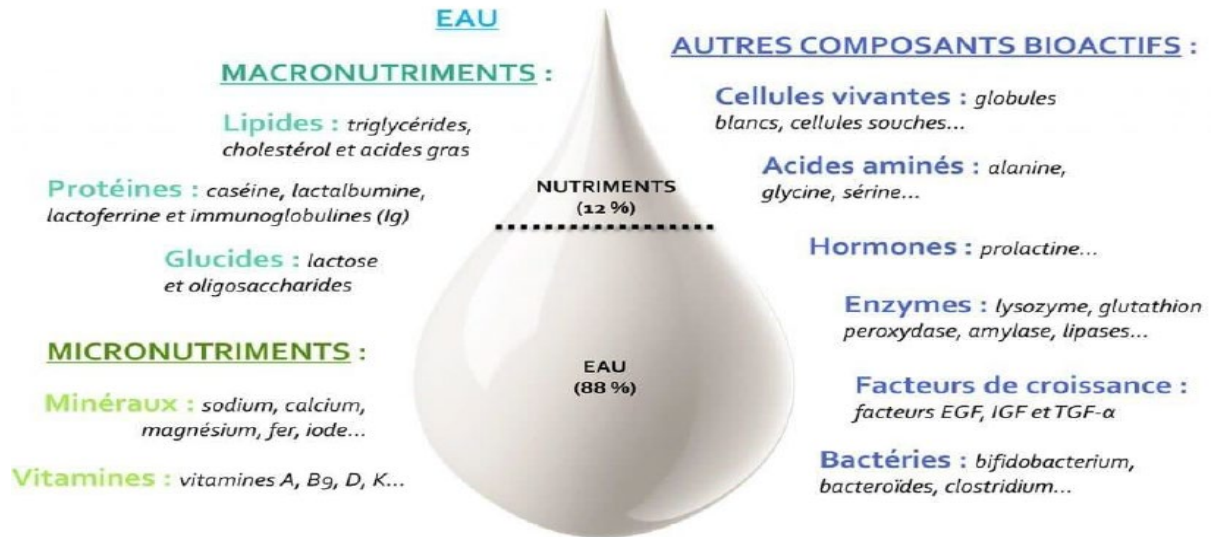
Leur proportion est dans un premier temps très déséquilibrés. La caséine représente au début de la production du lait de transition 90 % de sa proportion en protéines de lait pour passer à 60/40 après quelques mois d'allaitement.

Après 1 mois d'allaitement, nous retrouvons généralement un **lait qu'on appelle « mature »**.

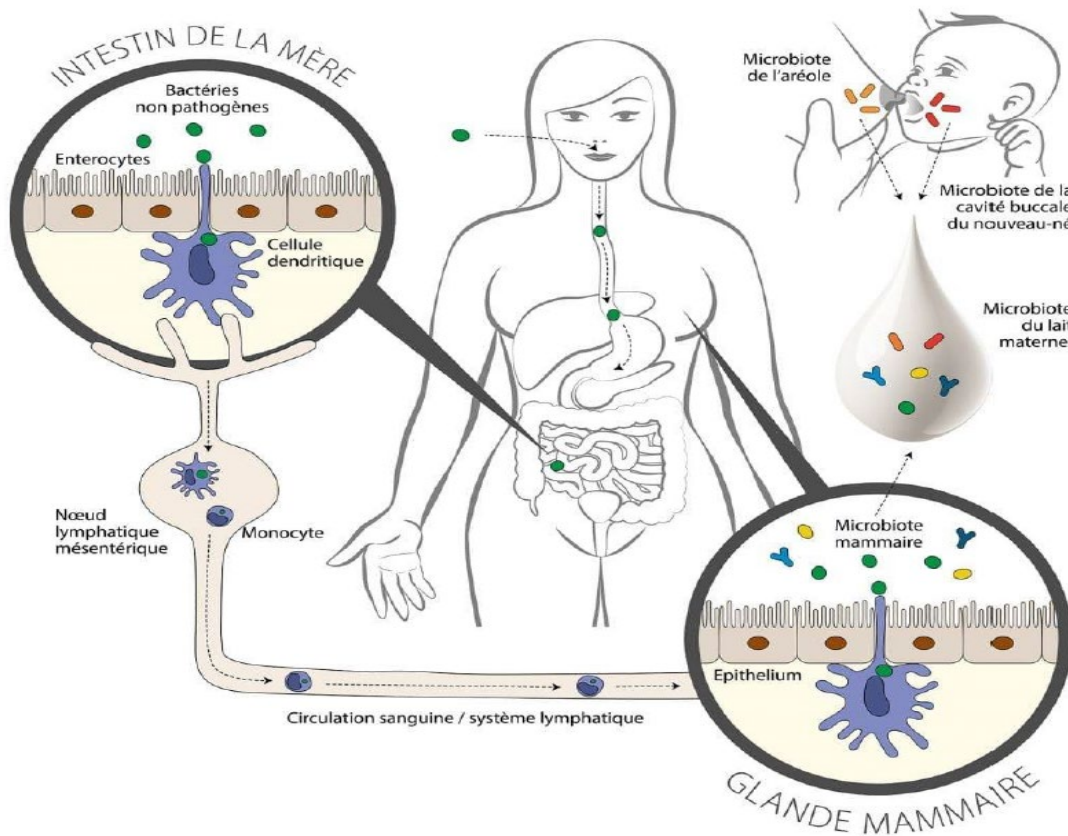
Le lait mature est riche en :

- **Eau (87 %)** : hydratation de l'enfant
- **Glucides (7%)** : majoritairement du lactose

- **Lipides (4 %) : triglycérides**, présentes surtout en fin de tétée. La teneur en lipides du lait maternel peut varier en fonction de l'âge de l'enfant, de l'alimentation de la mère, l'heure de la journée et le moment de la tétée (taux lipides principalement des triglycérides)
- **Protides (1%)** : Protéines, enzymes, acides aminés et hormones
- **Micronutriments (0.5%)** : Oligo éléments et vitamines
- **Leucocytes** : facteurs immunitaires
- **Bactéries** : microbiote transmis à l'enfant.



<https://nutrixel-info.fr/le-lait-maternel-un-vivier-de-tresors-nutraceutiques-pour-petits-et-grands/>



Variations subit :

- **Au cours de la tétée** : plus hydratant en début de tétée, plus riche en lipide en fin de tétée.
- **Au cours des 24 h** : Riche en cortisol le matin, plus de lipides le midi, plus de protéines le soir, plus de mélatonine la nuit favorisant l'endormissement de la mère et de l'enfant.
- **Lors de l'allaitement** : colostrum, lait de transition, lait mature.



3. Manifestation physique

L'allaitement est très **énergivore** pour la femme. **Le lait est produit tant que la stimulation est présente.**

La production de lait entraine :

- **Un meilleur sommeil** pour la mère et l'enfant
- **La production d'hormones stimulantes pour la maman** (ocytocine, prolactine, endorphine, dopamine)
- Un meilleur repositionnement de l'utérus
- **Un recul du retour de couche**
- **Une baisse du risque hémorragique**
- Sur du plus long terme une **baisse du risque du cancer du seins et ovaire et une meilleure minéralisation osseuse.**
- Perte de poids de grossesse.

Lors de la grossesse :

- **Les œstrogènes aident à l'allongement des canaux galactophores.**
- **La progestérone, la prolactine et la HLP permettent le développement des lobules mammaires.**
- **La progestérone empêche la production de lait.**

Lors de **l'accouchement**, il y a une **chute d'œstrogène et de progestérone.**

La prolactine déclenche la production de lait.

L'ocytocine déclenche son éjection.

Le nombre de tétée est de **8 à 12 au début de la vie de l'enfant**. Le **nombre est important pour stimuler** correctement la lactation et permettre de produire régulièrement la prolactine nécessaire à la production du lait.

Les **canaux galactophores** des seins sont allongés, les **lobules** sont développés et **produisent le lait** grâce à la **filtration du sang**.

4. Les hormones

- **Prolactine** : Production de lait, meilleur sommeil lent et profond
- **Ocytocine** : Ejection du lait, attachement à l'enfant, détente somnolence et récupération
- **Dopamine et beta-endorphine** : Plaisir et bien-être, réveil dynamique et entrain.

Vidéo voir support slide 67

VI. LA REPRISE DU CYCLE

1. Manifestation physique

À la suite de l'accouchement :

- **Les lochies** (pertes de sang après accouchement) sont présentes jusqu'à **4 semaines** après l'accouchement
- **Le petit retour de couche** à lieu **15 à 20 jours après l'accouchement**. Il s'agit de **saignements plus importants** qui peuvent faire penser à un retour de règles, c'est la **cicatrisation de l'utérus**.
- **Sans allaitement** : Le **retour de couche** à lieu **6 à 8 semaines** après l'accouchement
- **Avec allaitement** : Le **retour de couche** se fait lorsque que **l'allaitement diminue ou s'arrête** (diversification alimentaire de l'enfant)

Le retour de couche :

- Les **premières règles** sont en générales **plus longues et importantes**, c'est normal.
- Les **cycles sont souvent irréguliers les premiers mois**
- Les **SPM** sont **plus importants ou différents** que précédemment
- **Attention l'ovulation se fait avant le retour de couche donc pas de règles ne veux pas dire pas d'ovulation.**

2. Hormones

La prolactine produite lors de **l'allaitement retarde la reprise des cycles**.

Lors de **l'accouchement** la **baisse de progestérone et d'œstrogènes** induit une reprise de **production de FSH et de LH**.

La reprise prend son temps le corps à besoin de se réadapter à cet évènement qu'il a subi.

Durant la période de retour de couche, il est important de faire attention à sa contraception s'il n'y a pas de désir de nouvelle grossesse.

VII. Conclusion

Nous avons fait le tour de toutes les possibilités qu'offre le système gynécologique de la femme.

De la puberté à la ménopause en passant par la grossesse, ce système offre des possibilités importantes.

N'oubliez pas que tout cela est régulé par des hormones, que le corps humain a besoin de temps pour s'adapter, et que généralement, tout a une utilité et une fonction.

Les hormones sont les éléments de fonctionnement de ce système. Sans elles, il ne serait pas possible de donner la vie.